

Et donc je vais maintenant simplement montrer les lignes de force pour aller de la périphérie vers la base du crâne, pour rééquilibrer finalement la face en rapport avec le cerveau. Le cerveau neurocrâne et viscérocrâne s'articulent d'une certaine façon sur cette symphyse phénobasilaire. Et donc je ne peux pas ne pas traiter les deux ensemble, si tu veux. Je dois le prendre dans une idée. A la fois j'ai tout le système nerveux que je traite par rapport à tout mon système viscéral. Et je vais les rééquilibrer simplement. Le bébé passe de l'ombilique au niveau buccal. Il doit être capable de ramener toute l'information au niveau de la bouche. Si vous observez un bébé qui ne se rassemble pas, attention, il faut l'aider à retrouver ce rassemblement en lui, pour qu'il puisse ramener les choses vers sa ligne médiane. Un enfant, en fait, il devient extrêmement buccal. C'est une zone de survie, il doit tout ramener à sa bouche et donc il aime bien, en fait, qu'on lui donne un point d'appui. Que ce soit en position assise, tout petit bébé, je ne traite rarement le crâne. D'abord je traite le bassin, le viscéral, je vais rarement au crâne. Si je vais au crâne, je donne un point d'appui au niveau de la mâchoire, mais je touche rarement la tête. Il ne faut pas trop aller tout de suite là-dessus. Par contre, il faut un petit peu indiquer certains conseils. L'enfant, c'est d'abord un ventre. Si vous n'êtes pas juste, il va très vite vous le montrer. Suivez ça. D'abord, détendez bien le bassin, détendez bien le sacrum, détendez bien la zone digestive. Et si c'est nécessaire, détendez bien le médiastin. Et s'il faut aller au crâne, travaillez bien de façon très très légère. Je vais prendre la gaine dural ici. Une gaine dural moyenne. Que je vais prendre comme ça. Plus vous touchez léger, plus vous allez dans la profondeur. Je laisse l'anatomie se visualiser dans mon corps. Je vais dire ça comme ça. Voilà, je le laisse bien comme ça. Donc comme c'est une densification un peu différente, ça veut dire que c'est un champ électrique un peu plus fort. C'est une gaine dural, donc je touche d'abord de la périphérie. Voilà.

Elle peut sentir comme si je rentrais un peu plus profond. Peut-être que tu peux percevoir ça. Il y a une toute petite déviation, enfin déviation, c'est-à-dire qu'il m'amène un tout petit peu en torsion. Donc elle a un petit point d'appui. Je l'ai vu, donc je ne rentre pas. Soit je pars dans le fascia, mais là je ne pars pas. Je pars plutôt dans une écoute biodynamique. Donc je reste sur la santé. Je ne me laisse pas hypnotiser par la lésion. Il est attiré. Et je reste dessus. Voilà, j'attends. Mais je suis dans la globalité. J'ai une vision de la globalité. Ça veut dire que je tourne la page. Donc si je suis attiré tout d'un coup vers une tension, une lésion, je ne rentre pas dedans. Je suis dans ma tête, je dis « Ah, je t'ai vu, c'est bon ». Non, je ne cherche pas les deux. Je reste sur la santé. Pas plus loin dans la lésion, mais plus loin dans la profondeur quand même. Oui, là maintenant, je me mets sur cette fréquence. Donc je peux me mettre, tu vois ici, sur une fréquence purement des cheveux. Voilà, je viens, je change, je reviens sur les cheveux. Puis je vais plutôt sur une fréquence, des qualités fréquentielles différentes. Je vais sur la peau. Voilà. Je vais plutôt sur un tissu plutôt osseux. Voilà. Pour moi, je suis encore peau. Voilà. Je suis passé de fréquence aux osseux. Là, je descends. Là maintenant, elle peut le sentir. Normalement, elle peut percevoir ça. C'est différent. C'est comme si je rentrais tout doucement. L'os et la dure-mère, c'était la même chose. C'est juste une densification à un moment donné. Voilà. Là, je me mets là. Là, je vois et je reste là. Mais je suis toujours dans la globalité. Mais si tu me dis quelle est mon intention, je reste sur le pattern de la santé. Non, non, non, non. Là, je suis dans une immobilité. Mais en même temps, je me mets dans cette ligne, dans cette approche anatomique de ma ligne, de ma gaine dure à elle, l'épaississement, dans la globalité, en restant sur la santé. Donc je ne pars pas dans une lésion. Donc là maintenant, ici, je voulais juste te faire sentir ce champ ici. Est-ce que tu as perçu ? Maintenant, je me mets ici. Et là, je vais me mettre sur cette gaine ici. Voilà. Et je me mets

ici. Je prends l'arc mandibulaire One. Mes deux lignes se rejoignent ici, tu vois, au niveau de la symphyse. Donc je vais attendre tout doucement qu'il y ait cette connexion, si tu veux. Voilà. Donc je me mets dans les champs de forme. Donc je suis sur la suture coronale, en fait. Si. Et je sais que ces deux lignes, c'est comme des arceaux. Ils se rejoignent tous sur la place publique. Je sens la zone qui travaille. Et même si c'est tout léger, c'est lourd en profondeur. Ça c'est la biodynamique, c'est-à-dire que c'est le corps qui travaille là, moi je donne son point, voilà. Maintenant elle va sentir quelque chose, voilà, je vais te décrire, je vais t'aider, parce que tu ne sais pas très bien ce que tu as ressenti, mais tu as senti quelque chose de plus unitaire. Donc simplement revenir vers ce niveau-là, laisser le système. Là j'étais jusque sur un autre niveau, c'est différent, tu as un peu joué sur des plans thémiques, donc c'est aussi des correspondances anciennes sur les niveaux du ring antérieur, donc on va voir chez mademoiselle si on peut un tout petit peu l'aider sur un niveau, donc elle a quand même un peu enregistré dans son disque dur quelques trucs, donc je vais essayer de te faire sentir, je vous ferai sentir une concentration de temps, donc elle a quand même ici une belle concentration, c'est pas un noeud, c'est pas un noeud, il y en a un ici, ça fait un peu mal, je vais juste le dégager ici, Dégagez-s'y. donc ça c'est une mémoire ancienne, Voilà, on libère ça, voilà. C'est un petit peu piqué, ouais. Ça sera, ça va ? Ok, à vous.